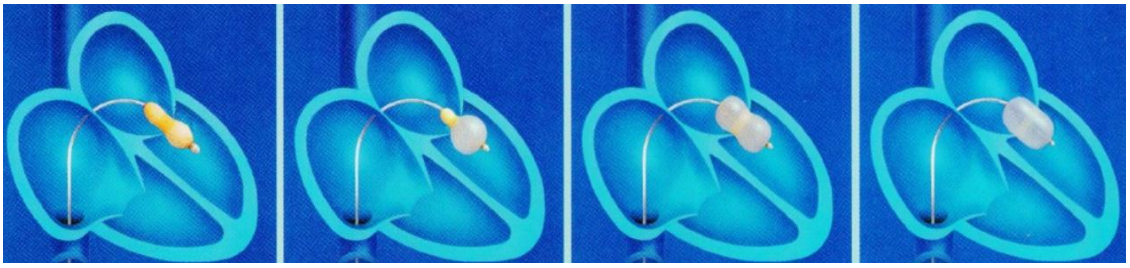
2.择期 弹性还可以

①**有开瓣音：经皮球囊二尖瓣成形术（介入）**整形

②无开瓣音：直视分离术

③经皮球囊二尖瓣成形术失败、或二狭合并中重度二闭等：人工瓣膜**置换术**（外科手术）废了



主A 左房 收缩期 左室

二、二尖瓣关闭不全（二尖瓣反流）

瓣膜狭窄:慢性
瓣膜关闭不全:慢性.急性

（一）病因

常见原因

①风湿病（急性风湿热形成慢性二闭至少需要 20 年）

②黏液样变性致脱垂

③**急性心梗（乳头肌功能不全或断裂）** 收缩期 左房 左室

④感染性心内膜炎（瓣叶穿孔、腱索断裂后可致急性二闭）等

（二）临床表现

1.杂音 左心室血液一直往左心房反流

①**心尖、全收缩期、一贯型杂音，常吹风样**，前叶损害为主杂音向左腋下和左肩胛下传导、后叶损害为主向心底传导

②杂音强度与左室收缩力强弱有关、而与反流程度**不一定**成正比

③海鸥鸣或乐音提示腱索断裂 →二尖瓣脱垂

④可致相对性二狭（心尖舒张中期隆隆样杂音）

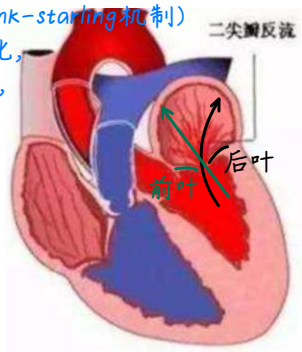
关闭不全 左房 左室 血多了 收缩期 舒张期 血多 左房 左室 打工人挤地铁

VS 器质性二狭：心尖部舒张中晚期 功能性的杂音早期声音太小听不到 也不会持续太久到晚期

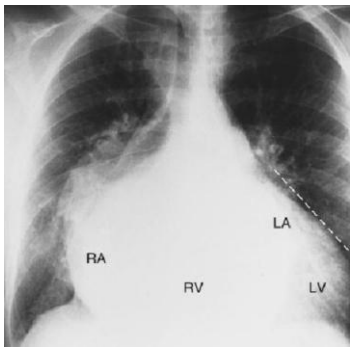
2.左室变化 狭窄只有慢性的,关闭不全既有急性又有慢性

慢性二闭 左心室大小不一样	急性二闭 来不及代偿
后期离心性肥厚（室壁轻度肥厚、心腔容积显著增大）	早期扩大、心腔容积正常或轻度扩大，室壁无肥厚

早期左心房给左心室的血变多(前负荷↑),
可以通过异长调节机制(Frank-Starling机制)
增加心肌收缩力射出去。因此,
早期左心室不会有大小变化,
后期心室肌离心性肥厚,
让自己能装更多的血
(期间有等长调节参与)



心脏急性扩张能力有限(心肌伸展性小)



压力负荷↑ 向心性肥厚

容量负荷↑ 离心性肥厚

（三）治疗

瓣膜置换术、修复术（用于二尖瓣脱垂）

只是腱索、乳头肌的问题
瓣膜没有特别明显损害